

Урапидил

Периферический α_1 -адреноблокатор + центральный агонист 5-HT_{1A}-рецепторов · Эбрантил / Тахибен

ФОРМА ВЫПУСКА

0,5 % · 5 мл = **25 мг**
5 мг/мл

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Периферическое действие: блокада α_1 -адренорецепторов сосудов приводит к расширению артериол и снижению общего периферического сосудистого сопротивления. Центральное действие: стимуляция серотониновых 5-HT_{1A}-рецепторов в стволе мозга подавляет симпатический отток и предотвращает рефлекторную тахикардию. Начало эффекта через 2–5 минут. Период полувыведения 2,7 часа. Метаболизм печёночный.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
Гипертонический криз (первый этап)	25 мг (5 мл) в NaCl 0,9 % до 10 мл; вводится половина раствора (12,5 мг) за 5 мин	в/в медленно
Через 5–7 мин нет снижения АД на 15–25 %	вторая половина раствора (12,5 мг)	в/в медленно
Криз при САД $\geq$ 200 мм рт. ст. (онкология, реанимация)	12,5 мг (2,5 мл) ; снижение САД не более 10 % от исходного	в/в медленно
Инсульт, инфаркт мозга (только САД > 200)	12,5–25 мг (2,5–5 мл) ; снижение не более 15 %	в/в медленно
САК / внутримозговое кровоизлияние (САД > 180)	12,5–25 мг (2,5–5 мл) ; снижение не более 15 %	в/в медленно
Дети до 18 лет	противопоказан (данные отсутствуют)	

Цель: снижение на 15–25 % от исходного за первый час. При достижении целевого снижения введение прекращается. Резкого снижения не допускать.

НАСОС 31-Р 5 мл (25 мг) + 15 мл NaCl 0,9 % = 20 мл (**1,25 мг/мл**); 120 мл/ч → 12,5 мг за 5 мин → стоп → оценка АД → при необходимости вторая половина раствора.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Критический аортальный или митральный стеноз — фиксированный сердечный выброс, резкое падение артериального давления при снижении ОПСС
- Гиповолемия (диуретики, рвота, этанол) — сниженный объём циркулирующей крови не позволяет компенсировать вазодилатацию
- Препарат не снижает преднагрузку и не заменяет нитраты при отёке лёгких
- Горизонтальное положение пациента обязательно — риск ортостатического коллапса

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТАКТИКА

- Феохромоцитома: сначала α -блокада (урапидил), затем бета-адреноблокатор (метопролол); обратный порядок опасен
- Презкламсия: препарат первого ряда — нифедипин 10 мг внутрь (раздел 9 Алгоритмов), не урапидил
- Разведения: болюс — 25 мг в 10 мл NaCl (2,5 мг/мл); насос — 25 мг в 20 мл (1,25 мг/мл); концентрации различаются
- Артериальная гипертензия без криза: моксонидин или каптоприл внутрь; урапидил не показан